

- פנטאניל
- פוסיד
- ניטרוגליצרין (איזוקט תרסיס/אמפולות)

פרוצדורות רפואיות שיכולות לגרום לירידת לחץ דם:

- תמרון ולסלבה (Valsalva maneuver)
- הכנסת עירוי תוך-ורידי ובעקבותיה ירידת לחץ הדם בגלל תגובת מטופל למראה המחט או הדם (vasovagal reflex)
- אינטובציה

שלבי מדידת לחץ דם

- (1) מניחים את שרוול על יד המטופל; יש להצמיד היטב את השרוול (המנג'טה) לזרוע אך ללא הפעלת לחץ
 - (2) מנפחים עד להפסקת דופק באותה היד
 - (3) מורידים את הלחץ באיטיות
 - (4) כששומעים מערבולת ראשונה - זהו לחץ הדם הסיסטולי
 - (5) כשנעלמת המערבולת - זהו לחץ הדם הדיאסטולי
- אפשר למדוד לחץ דם סיסטולי בלבד, ללא שימוש בסטתוסקופ, על ידי זיהוי הרגע שבו מתחילים למשש דופק.
- יש לשים לב שיש הבדלים בין לחץ הדם אם המטופל יושב או שוכב ובין הידיים של המטופל (במצב נורמלי: הבדל של עד 10%). למשל הבדל גדול בלחץ הדם בין שתי הידיים יכול להעיד על מפרצת של אבי העורקים החזי.

גלוקומטר ומדידת סוכר



תמונה 25.17 שימוש בגלוקומטר

גלוקו = סוכר; מטר = מודד

הגלוקומטר הוא כלי עבודה חשוב בעבודה בנט". המכשיר בודק את רמת הסוכר בדם של הנבדק ועל ידי כך מסייע לצוות הנט"ן לקבוע אבחנה.

במד"א יש כמה דגמים של גלוקומטרים אולם העיקרון בכולם זהה. ראשית מכניסים את קצהו המתאים של מקלון הבדיקה למכשיר הגלוקומטר, המכשיר יידלק ברגע הכנסת המקלון. מניחים טיפת דם מהמטופל על אחד מקצותיו של מקלון הבחינה (סטיק) במקום המסומן לכך. המכשיר ימדוד את רמת הסוכר בטיפה בתוך כמה שניות ויציג תוצאה.

יש שלוש תוצאות אפשריות:

- **מספר** - על הצג יופיע מספר המציין את רמת הסוכר ולפיו מטפלים במטופל.
 - **Lo/low** - כשסימן זה מופיע פירוש הדבר הוא שרמת הסוכר בדגימה נמוכה מיכולת הבדיקה של המכשיר. בדרך כלל מדובר על רמות של מתחת ל-30 מ"ג אחוז. יש להתייחס למספר המתקבל במכשיר ולטפל במטופל היפוגליקמי לפי הפרוטוקול.
 - **HI** - כשסימן זה מופיע פירוש הדבר הוא שרמת הסוכר בדגימה גבוהה מ-450 מ"ג אחוז. המטופל זקוק לנוזלים, אשלגן ואינסולין.
- במיד"א יש דוקרן חד-פעמי שנועד לבדיקה זו כך שיהיה אפשר לקחת דגימת דם גם ללא פתיחת וריד. מחטאים באלכוהול את האצבע המיועדת לדקירה ודוקרים בעזרת הדוקרן. מנקים את טיפת הדם הראשונה מחשש שחומרים שהיו על העור יעוותו את הבדיקה. את מקום הדקירה יש לכסות לאחר מכן בגזה ולהדקה למקומה בליוקופלסט.

טיפול

- רמת הסוכר הנורמלית היא 70 - 100 מ"ג אחוז (מ"ג למאה מ"ל). ולכן לכל תוצאה של מתחת ל-70 או low בגלוקומטר יש להתייחס כאל היפוגליקמיה ולטפל מייד בהתאם: מתן גלוקוג'ל תת-לשוני למטופל בהכרה מלאה או דקסטרז IV למטופל מחוסר הכרה או בהכרה מעורפלת.
- מדידה שמראה תוצאה של מעל 180 או HI בגלוקומטר, יש להתייחס למצב כאל היפרגליקמיה ולטפל בהתאם.
- כל מדידה שבין 70 ל-180 מצביעה על רמת סוכר תקינה בדם, ולכן יש לנסות למצוא את מקור הבעיה של המטופל בסיבות אחרות.

מד רוויון החמצן בדם (פולס אוקסימטר, Pulse oximeter)



תמונה 25.18 מד רוויון החמצן בדם (פולס אוקסימטר, Pulse oximeter)

רוויון החמצן בדם הוא אומדן חשוב להערכת המצב הנשימתי וההמודינמי של הנפגע בשלב B. לא די בפתיחת נתיב אוויר, המטרה היא לחמצן את תאי הדם האדומים כדי שיתאפשר חמצון תקין של הרקמות. מכשיר הפולס אוקסימטר (pulse oximeter) מודד את שיעור רוויון החמצן בדם. המכשיר בנוי בצורת אטב ובתוכו מניחים את אחת האצבעות.

פתיחת האטב וסגירתו נעשית על ידי לחיצה קלה על החלק המרוחק מהחוט. בתוך האטב, בחלק שבו נכנסת האצבע, יש חיישן. המכשיר מתעלם מהגלים שאינם פולסטייליים (פועמים) וקורא את רוויון החמצן בעורקים בלבד. רוויון החמצן אצל אדם בריא הוא 95%-100%.